

Seksuaalkurjategijate kohtlemine karistuse kandmise ajal



Linda Paap

vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse nõunik, justiitsministeerium

2015. aastal registreeriti Eestis 500 seksuaalkuritegu – 35% rohkem kui eelmisel aastal. 85% registreeritud seksuaalkuritegudest pandi toime laste vastu (Tammiste 2016).

Justiitsministeerium saatis 1. juunil kooskõlastusringile Lanzarote konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu, mis käsitleb laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest. Konventsiooni rakendamine eeldab riigi võimekust rakendada kuritegusid ennetavaid meetmeid nii kogukonnas kui ka vanglasüsteemis. Ennetus võib olla mõeldud

nii potentsiaalsetele seksuaalkuritegude toimepanijatele kui ka neile, kes on kuritegusid juba sooritanud.

Seksuaalkurjategijate retsidiivsus- ehk korduvkuritegevuse riski maandamisega tegelevad vanglad (sh kriminaalhooldus) ja raviastutused. Eelmise aasta jooksul kandis seksuaalkuriteo eest vanglakaristust (sh varem süüdimõistetud, kes olid 2015. aastal vähemalt ühe päeva arvel) 171 kurjategijat; kriminaalhooldusel oli 156 süüdimõistetut, kellest 21-le oli kohus määranud kohustusliku ravi.

Juhtumikorraldus vanglas

Kinnipeetavate taasühiskonnastamine toimub juhtumikorralduslikul põhimõttel, mida tutvustavad selles ajakirjanumbris Katriin Savits, Ülle Luts ja Asta Vaks, lk 8–11.

Nagu ka teistel kinnipeetavatel, nii ka seksuaalkurjategijatel jaotub vangistus vastutuftaasiks, põhifaasiks ja vabastamisjärguks. Vastutuftaasis aidatakse kinnipeetaval võimalikult sujuvalt vanglaeluga kohaneda, andes talle vajalikku informatsiooni vangistuses viibimise kohta. Siis viiakse läbi ka riskide hindamine Suurbritanniast üle võetud ja Eesti oludele kohandatud teaduspõhise metoodikaga. Kinnipeetavad paigutatakse vanglasse vastavalt riskihindamise tulemusele. Seksuaalkurjategijad paigutatakse Tartu vanglasse (*Täitmisplaan* 2016), kus nendega töötavad spetsialistid, kel on selleks süvateadmised.

Vanglas tehakse kindlaks, kas isik on toime pannud vähemalt ühe kontaktse kuriteo. See tähendab otsese füüsilise kontakti kõrval ka juhtumeid, kus isik oli ohvriga visuaalses kontaktis (ekshibitsionism) või kontaktis interneti kaudu (lapse kohtumisele meelitamine internetis). Interneti kasutamist (lapsi kujutavate) pornograafiliste teoste allalaadimiseks ja jagamiseks aga ei loeta kontaktseks teoks. Kui isik pole toime pannud ühtegi kontaktset seksuaalkuritegu, siis koheldakse teda teiste kinnipeetavatega samadel alustel. Kontaktse teo sooritanuile viiakse aga läbi spetsiaalne Kanada teadlaste välja töötatud seksuaalkurjategijatele mõeldud riskihindamine. Vangla tingimustes on sel kaks osa: *Static-2002* ja *Stable-2007*.

Static-2002 on muutumatutele või meie tahtest sõltumatult muutuvatele (vanus muutub aja jooksul) tegurite mõõtmisvahend, mis lähtub statistilistest näitajatest. Vaadeldakse viit tegurit: vanus, seksuaalkuritegude korduvus, hõlbelised seksuaalhuvid, sugulus ohvritega ja üldine kuritegevus. Tegurite

hindamiseks kasutatakse 14 alaküsimust. Hinnangu tulemusel saab tuvastada pikaajalise uue kuriteo riski taseme.

Kuna hindamine põhineb staatilistel tunnusel, võib esmapilgul tunduda, et riskid on muutumatud või muutuvad ainult koos kurjategija vanusega. Õnneks see siiski nii ei ole. Keegi ei saa muuta olematuks isiku sooritatud kuritegusid või hõlbelisi seksuaalseid eelistusi, mis mõlemad suurendavad uue seksuaalkuriteo toimepanemise tõenäosust. Kuid spetsialistid saavad aidata kurjategijal retsidiivsusriski kontrolli all hoida, õpetades probleemilahendusoskusi ja enesekontrolli. Need on dünaamilised ehk ajas muutuvad riskitegurid, mis mõjutavad riskikäitumist kas positiivses või negatiivses suunas (Grünberg 2013). Muudetavaid tegureid on teisigi, seega on sekkumisvõimalusi mitu.

Muutuvatel näitajatel põhinev hindamisvahend *Stable* aitab mõõta lühemaajalist (ühe aasta pikkust) retsidiivsusriski. Selle vahendi kasutaja peab oskama professionaalselt hinnata isikute suhteid, hoiakuid ja oskusi. Kuna sellise taseme saavutamine nõuab nii aega kui ka kogemust, kasutatakse vanglasüsteemis riskihindaja esimesel kahel tööaastal n-ö topelt-hindamist, kus lõpphinnang antakse koos kogenud mentoriga. Keerulisemate juhtumite puhul kasutatakse seda võimalust ka hiljem.

Static ja *Stable* hindamiste tulemusi kombineerides tehakse kindlaks, kui suur on risk, et isik sooritab uue seksuaalkuriteo. *Stable* hindamisega leitakse lisaks riskitegurid, mis on isiku kuriteole kallutanud, kuid mis on muudetavad. Hindamise tulemuste põhjal planeeritakse kinnipeetavate karistusaega, st määratakse tegevused ja nende ellu viimise ajakava.

Madala riskitasemega seksuaalkurjategijaid koheldakse nagu teisigi kinnipeetavaid ja riske maandatakse üldistel alustel. Süüdimõistetud, kelle *Static* ja *Stable* kombineeritud riskitase

on madal-möödukas või kõrgem, paigutatakse seksuaalkurjategijate üksusesse, sekkumistegevusi planeerides lähtutakse ennekõike uue kuriteo riski maandamisest.

Koos seksuaalkurjategijatega on eriuksuses ka kinnipeetavaid, kes on süüdi mõistetud teistsuguste kuritegude eest. See aitab vähendada seksuaalkurjategijate märgistatust. Üldjuhul on suhtarv 1:3. Teised kinnipeetavad on keskmisest madalama riski ja keskmisest lühema karistusajaga.

Sekkumistegevuste planeerimine

Vangistuse põhifaas keskendub eelkõige süüdimõistetud uue kuriteo riski maandamisele. Sekkumistegevusi planeeritakse kinnipeetava individuaalsesse täitmiskavasse. Mõned tegevused, näiteks töötamine, on teatud kinnipeetavatele kohustuslikud (*Vangistusseadus* 2016). Tartu vangla seksuaalkurjategijate kohtlemise mudeli alusel läbivad kurjategijad karistusaja esimesel aastal sekkumisprogrammi „Uus suund”.

Sekkumistegevusi planeeritakse riskist, vajadusest ja vastavuse printsiipidest lähtudes (Andrews ja Bonta 2015). Riski printsiipi järgides tuvastatakse kõrgema riskiga isikud ja neile määratakse rohkem sekkumistegevusi. Ressursid on piiratud ja kõigile neid lihtsalt ei jätku. Kõrgema riskiga isikute puhul on sekkumistegevuste tulemuslikkus ka oluliselt suurem, madala retsidiivsusrisi puhul on see pea olematu (Lowenkamp jt 2006).

Vajaduse printsiibi põhimõte on, et kinnipeetavatele määratud sekkumised vastavad nende vajadustele – sekkumistegevused peavad maandama riskihindamise käigus tuvastatud muudetavaid riskitegureid. Kehtib printsiip, et tuleb lähtuda isikust ja tema vajadusest, mitte vangla võimalustest. Tegeleda tuleb kõigi kuritegelikkude käitumist mõjutavate riskiteguritega, seda ka siis, kui vanglal pole

võimalik pakkuda sobivat sekkumisprogrammi. Sel juhul kasutatakse individuaalset nõustamist.

Seksuaalkuriteod ja nende toimepanemise asjaolud on väga erinevad, seega peavad erineva ka lähenemised. Võtame näiteks lastevastased kuriteod. Kõik lapsi seksuaalselt ära kasutavad isikud ei ole pedofiilid. Üpris tihti juhtub, et seksuaalkuriteo toimepanija elaks hea meelega seksuaalelu täiskasvanud partneriga, kuid ta lihtsalt ei oska nendega suhteid luua ja hoida. Ta suhtleb ainult lapsealustega, kuna see on lihtsam. Sel juhul tuleb inimesele õpetada uusi oskusi. Tarvis on nii sotsiaalseid oskusi, mis aitavad luua suhteid lubatud partneriga, kui ka oskust mõista oma tegude tagajärgi. Teo toimepanijad ei mõista tihtipeale, kui rängalt mõjus see kannatanule, eriti siis, kui nad ei kasutanud otsest vägivalda. Pedofiilil on seksuaalne orientatsioon lastele. Sel juhul ei ole suhtlemisoskuste arendamisest kasu, arendada tuleb hoopis enesekontrolli.

Vastavuse printsiip tähendab seda, et iga sekkumistegevust kavandades tuleb arvestada individuaalseid, sotsiaalseid ja isiksuslikke asjaolusid, mis võivad mõjutada sekkumise efektiivsust. Näiteks kui isiku kognitiivne võimekus ei võimalda tal sekkumisprogrammist aru saada, siis tuleb seda lihtsustada ja vajadusel ka programmi läbimise aega pikendada. Seksuaalkurjategijate puhul on üsna tavaline toime pandud tegu eitada. See ei mõjuta kuidagi uue kuriteo riski, kuid võib mõjutada sekkumistegevusi. Absoluutse eitamise puhul tuleb esmalt jõuda seisuni, mis võimaldab teo põhjuste ja ajendite analüüsi.

Seksuaalkurjategijate sekkumisprogramm on olemuselt motiveeriv ega eelda oma tegude täielikku tunnistamist, eitamise vähendamiseks kasutatakse ka motiveeriva intervjuerimise võtteid.

Seksuaalkurjategijad saavad osaleda ka individuaalses psühholoogilises või sotsiaalses nõustamises ja perenõustamises ning läbida

teiste riskivaldkondade (sõltuvus, pere- ja paarisuhte vägivald) programme või sotsiaalsete oskuste arendamisele keskendunud tegevusi. Nad võivad omandada haridust (sh õppida riigikeelt) ja töökogemust, arendada oma peresuhteid (nt lühi- ja pikaajalised kokkusaamised lähedastega) ja osaleda usulises tegevuses.

Arenguvõimalusi on praeguses süsteemis veel palju. Oskame üsna hästi vahet teha eri riskitasemetega isikutel, kuid neile tegevusi kavandades lähtume vaid jaotusest madala ja madalast kõrgema taseme vahel. Saame pakkuda individuaalnõustamist, kuid suur puudus on kõrge riskitasemega isikutele mõeldud spetsiaalsest grupiprogrammist, selle ostmine on plaanis lähiaastail.

Sekkumisprogramm „Uus suund”

Kognitiiv-käitumuslikul teorial põhineva sekkumisprogrammi „Uus suund” eesmärk on aidata seksuaalkurjategijal mõista enda tegu, analüüsida selleni viinud asjaolusid ning liikuda selle poole, et elada tulevikus ilma kuritegusid toime panemata ja hälbiva seksuaalhuvita. Otsitakse üles isikut kuritegelikule teele suunavad mõttevead ja leitakse neile positiivse mõjuga alternatiivid. Programm põhineb muu hulgas hea elu mudelil (ingl *Good Lives Model*), mis keskendub isiku positiivsetele eesmärkidele ja nende saavutamisele seaduskuulekal teel (Purvis jt 2014). Riskid maandatakse inimest jõustaval viisil: temas kasvab teadmine, et tema käitumine oli vale, kuid tal on võimalik liikuda universaalsete positiivsete eesmärkide poole.

Programm viiakse üldjuhul läbi kinnipidamise põhifaasi esimeses pooles, kuid jätkutegevused ja kinnistavad vestlused kestavad karistusaja lõpuni. Kuigi programm

määratakse kõigile seksuaalkurjategijatele, kõik seda ei läbi, sest osal kinnipeetavatest pole selleks piisavalt motivatsiooni. Kuigi kinnipeetavate motiveerimisega tegeletakse kogu karistusaja vältel, esineb siiski juhtumeid, kus riskimaandamiseks planeeritud tegevused jäävadki ellu viimata. Motivatsioonipuudus ei tähenda automaatselt kahetsuse puudumist, pigem on tegu enesekaitsega – inimene keeldub sekkumisest, sest eitab oma kuritegu või vähendab selle kahjusid. Mõned kinnipeetavad arvavad, et nad on muutusotsuse juba vastu võtnud ega vaja enam psühholoogide abi. Enamasti väidavad kinnipeetavad, et nad asuvad muutuste tsükli (Prochaska jt 1992) säilitamise faasis; nendega vesteldes aga ilmneb, et tegelikult on nad kaalutlusfaasis.¹

Vabastamisjärg

Sisuliselt tegeletakse kogu vangistuse kestel kinnipeetavate vabanemiseks ettevalmistamisega, kuid vangistuse lõpuosas ehk vabastamisjärgus keskendutakse sellele, kas isikul on elu- ja töökoht ning millist toetust ta vajab.

Kuus kuud enne karistuse lõppu saab kinnipeetav alustada koostööd tugisikuga, kes toetab teda hiljem vabaduses. Kinnipeetaval on pärast vabanemist võimalik saada ka nõustamist koos ajutise majutusteenusega. Kinnipeetavale antakse teavet tema tulevases elukohas pakutavate tugiteenuste kohta ja vajalikud kontaktid (nt anonüümsed alkooolikud, anonüümsed narkomaanid jms).

Kui kinnipeetav kannab oma karistuse lõpu avavanglas, siis on tema naasmine ühiskonda järkjärguline ja toetatakse iseseisvuse saavutamist. Avavangla on suur soodustus, mida kinnipeetavad oskavad hinnata ja selle tingimusi üldjuhul ei rikuta. Avavanglas lisanud tavapärasele *Static* ja *Stable* hindamisele

¹ Prochaska muutuste tsükli kohaselt toimuvad muutused käitumises vastavalt kindlatele faasidele: eelkaalutus, kaalutus, otsus, aktiivne tegevus muutuse nimel, säilitamine. Säilitamise faasist liigub inimene tagasilanguse korral uuesti eelkaalutluse faasi. Faaside pikkus on erinev iga muutuse puhul, kuid nende järjekord on püsiv.

seksuaalkurjategijate akuutne hindamisvahend *Acute*. See keskendub seksuaalkurjategijate igapäevase käitumise muutustele ja aitab tuvastada riski tõusu konkreetsel ajahetkel. Näiteks kui isik loobub koostööst või on emotsionaalses kriisis, siis see näitab, et tal võib olla kõrgem kuriteo toimepanemise risk. *Acute* hindamist tehakse oluliselt sagedamini kui *Static* ja *Stable* hindamist. Kõrgema riski tasemega isikute puhul korraldatakse seda avavanglas vähemalt kaks korda kuus. Kuna aga isikud on pidevalt vangla töötajatega kontaktis, jälgitakse muutusi käitumises iga päev.

Tähtaegse vabastamise korral antakse juhtumikorraldus kokkuvõtva teatisega üle kinnipeetava tulevase elukoha omavalitsusele. Kohaliku omavalitsuse teavitust on seksuaalkurjategijate puhul väga oluline, sest neil on suur tõenäosus sattuda vabaduses tagakiusamise ohvriks, mis on oluline riskitegur. Samuti peab lastekaitsetöötaja saama tuvastada isiku ligipääsu potentsiaalsetele ohvritele, seda eriti juhul, kui isik on keeldunud osalemast kuriteopõhistes sekkumistegevustes. Kui isik asub elama oma ohvriga samasse kohta, siis vajab olukord kindlasti lisatähelepanu, sekkumise vajadus sõltub iga juhtumi üksikasjadest.

Kriminaalhooldus

Kinnipeetavate ennetähtaegse vabastamise korral antakse juhtumikorraldus üle kriminaalhooldusele. Riskide hindamine ja sekkumistegevused jätkuvad siis samadel alustel kui vanglas. Enne tähtaega vabanenu kohtub kriminaalhooldusametnikuga keskmiselt kaks korda kuus kriminaalhooldusosakonnas, lisaks toimuvad kodukülastused.

Kriminaalhooldusel tuleb täita karistusseadustikus määratud kontrollinõudeid, lisaks võib kohus hooldusalusele määrata teisi kohustusi (*Karistusseadustik* 2016). 2015. aastal määrati kriminaalhooldusel olnud seksuaalkurjategijatele kõige sagedamini

kohustus läbida sotsiaalprogramm, seda tehti 84 juhul. Alkoholi tarvitamine oli keelatud 47 ja narkootikumide tarvitamine 39 juhul, kohtu määratud kohtades viibimine ja/või isikutega suhtlemine oli keelatud 41 juhul, kohustus asuda tööle või omandada üldharidus või amet oli määratud 27 inimesele, 21 aga pidid minema ravile. Kõigil juhtudel ei olnud ravi vorm ja liik täpsustatud, alati ei peetud silmas ka seksuaalkurjategijate kompleksravi justiitsministri 04.06.2013. aasta määruse mõistes (*Kompleksravi...* 2016).

Mainitud kompleksravi on vangistuse osalise asendusena võimalik määrata neile täisealistele isikutele, kes on kuriteo toime pannud nende ravitava või kontrollitava psüühikahäire tõttu ning kellele määratud karistusaeg on kuus kuud kuni kaks aastat ja kes on raviga nõustunud (*Karistusseadustik* 2016). Kompleksravi osutab justiitsministeeriumi lepingu alusel OÜ Arstlik Perenõuandla, ravimeid täiendab psühhoteraapia. Medikamentoosne ravi ei tähenda automaatselt nn hormoonravi, tegu võib olla ka näiteks antidepressantraviga. Ravi määrab iga juhtumi puhul raviarst. Seni on kompleksravi määratud üksikutele isikutele. Käitumiskontrolli kohustusena määratud ravi tähendab üldjuhul psühhiaatri vastuvõtule pöördumist ning edasist ravi psühhiaatri määratu põhjal (vt Rammul jt 2010).

Seksuaalkurjategijatega töötavate kriminaalhooldusametnike sõnul on suurim probleem häbimärgistamine, mis tabab seksuaalkurjategijaid vabaduses. Sellega kaasnev tugev meeleolulangus on aga riskitegur. Lisaks ühiskondlikule hukkamõistule kohtavad need inimesed halba suhtumist ka ametiasutustes. Raske on leida spetsialisti, kes neid aidata oskaks või tahaks. Takistuseks on see, et psühhiaatritel jt spetsialistidel ei ole väljaõpet seksuoloogias. Teisalt on küsimus suhtumises. Kui spetsialist ei taha seksuaalhälvetega tegeleda ja on seisukohal, et seksuaalkuriteo toime pannud isikud väärivad

eluaegset häbiposti, mitte abi, siis temaga kohtunud teo toimepanijal kaob viimane lootus midagi muuta.

Seksuaalkurjategijatega töötavad spetsialistid taunivad nende kuritegusid sama tugevalt kui kogu ühiskond, kuid nad saavad aru, kui oluline on karistust kannnud inimesed taasühiskonnastada ning kaasa aidata uute tegude ärahoidmisele. Ka kõige pikem vanglakaristus saab kord otsa ja kui ühiskond ei aita inimestel oma probleemidega toime tulla, vaid süvendab neid, siis on tagajärjed dramaatilised. Kriminaalhooldusametnikud teavad ka juhtumeid, kus seksuaalkurjategija on abi leidnud. Neil juhtudel on spetsialistid tegutsenud eelarvamusteta, mis laseb tekkida usaldussuhtel. Head tööd on teinud nii terapeudid kui ka töötukassa tugiisikud. Heade tulemuste eelduseks on professionaalsus, tähtis on ka inimeste sobivus.

2015. aastal loodi seksuaalhälbe nõuandetelefon STOPP. Numbril 666 5120 võivad nõu küsida inimesed, kellel on küsimusi enda seksuaalkäitumise ja -hälvete osas, nende lähedased ja ka ametnikud (Abikeskused 2016).

Seksuaalkuritegude tagajärjed on seda-võrd rasked, et sellel teemal peavad paratamatult koostööd tegema paljud asutused. Kriminaalhoolduse kestel korraldatakse regulaarselt ümarlaudu MAPPA meetodil (vt lähemalt Krista Schönbergi artiklist, lk 28–30).

Ümarlaudade läbiviimine tähendab ka seda, et kriminaalhoolduse lõppedes ei jää hooldusalune üksi – tema kõrval on toetavad spetsialistid, kes teavad, millised on tema riskid, vajadused ja tugevused. Selline koostöövorm on veel suhteliselt värske ja arengujärgus. Eelarvamustevabalt, uusi teadmisi ja oskusi omandades ning koostöös saame aga liikuda kõigi jaoks turvalisema ühiskonna poole. **S**

Viidatud allikad

- Abikeskuste kodulehekül.** <http://abikeskused.ee/nouandetelefon-stopp>. (23.06.2016).
- Andrews, D. A., Bonta, J.** (2015). *The psychology of Criminal Conduct*. Routledge: New York.
- Grünberg, M.** (2013). Kriminogeensete riskide hindamine. Justiitsministeerium.
- Karistusseadustik.** (2016). Riigi Teataja I, 21.06.2016, 23.
- Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend.** (2014). Riigi Teataja I, 07.01.2014, 7.
- Lowenkamp, C. T., Latessa, E. J., Holsinger A. M.** (2006). The Risk Principle in Action: What Have We Learned From 13 676 Offenders and 97 Correctional Programs? *Crime & Delinquency* 52(1), 77–93.
- Prochaska, J. O., DiClemente C. C., Norcross, J. C.** (1992). In search of how people change. Applications to addictive behaviors. *American Psychologist*, 47, 1102–1114.
- Purvis, M., Ward, T., Willis, G.** (2014). Applying the Good Lives Model of Offender Rehabilitation to Sex Offenders. The Safer Society Handbook of Adult Sexual Offense Assessment and Treatment. Safer Society Press.
- Rammul, I., Häidkind, R., Kraas, K., Alaver, P., Laas, L., Rang, P., Friedemann, K.** (2010). Ravijuhis seksuaalkurjategijate menetlemiseks. Tallinn.
- Seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord.** (2013). Riigi Teataja I, 01.06.2013, 28.
- Tammiste, B.** (2016). Seksuaalkuriteod. Kogumikus: Kuritegevus Eestis 2015. Tallinn: Justiitsministeerium. www.kriminaalpoliitika.ee/sites/kriminaalpoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuritegevus_eestis_2015.pdf. (23.06.2016)
- Täitmisplaan.** (2016). Riigi Teataja I, 21.04.2016, 10.
- Vangistusseadus.** (2015). Riigi Teataja I, 23.03.2015, 141.